Identifikace pacienta
Jméno pacienta: Jelen
Příjmení pacienta: **Otakar**
Rodné číslo:
Pojišťovna pacienta:

Zdravotní stav a diagnózy

Anamnéza: **Dne 10.8.2026 ve 4:30 náhle vzbuzen závratí a bolesti hlavy v zátylí a v šijí. Jelikož byl pracovně v Německu, byl vyšetřen v nemocnici v Koblenzi, kde diagnostikována vestibulární porucha. Doporučena hospitalizace, pacient ji preferuje v místě bydliště. Proto vyhledána rayonní ORL ambulance, kde odeslán k hospitalizaci pro pravostranný vestibulární syndrom. Pacient sledován na onkologii - stp. hemikolektomii l.dx pro ca. Bolesti hlavy jsou od 03/2026, proto zvažováno doplnění CT mozku onkologem. Nyní za hospitalizace na ORL doplněno CT mozku, kde intraoseální ložisko frontálně vpravo. V rámci MDT doporučena konzultace NCH, MR mozku a scinti skeletu (zobrazovací metody zatím nedoplněny, vyčkáme Vašeho doporučení). Onkologická dg.: ca. cekoascendens, pT3 pN0 cM0, adenoca., st.p. hemikolektomii l. dx., susp. Lynch syndrom, adjuvance 1 cyklus capecitabine, pak pro MSI nestabilitu nepokračováno. Disp. setrvale vyšší CEA kolem 6-7, CA19-9 norma (poslední hodnota 08/2026), restage CT hrudníku a břicha 7.9.2026 negat.**

Zobrazovací vyšetření: **CT mozku 13.9.2026: Infra ani supratentoriálně bez zřetelných ložiskových změn denzity. Komorový systém je přiměřené šíře, bez známek středočarového přetlaku. Zvyklé kalcifikace v epifýze a chorioidálním plexu. Gyrifikace symetrická, zachovaná. SA prostory nejsou rozšířené. Skelet- vpravo vysoko F neostře ohraničený hypodenzní skelet kalvy vel. minim 30x15x 35 mm, narušuje vnitřní laminu s hyperostot. propagací intrakrnaiálně extraaxiálně vel. 13x7 mm, přilehlý parenchym bez zjevného edému, zevní lamina kalvy lehce nepravidelné kontury, bez její kompletní destrukce. Kost je zde lokálně rozšířená. Drobný povrchová kožní výběžek vptavo vysoko F-P 6x1 mm re: intraoseální ložisko vpravo F s propagací intrakraniálně extraaxiálně- v diff.dg. intraoseální meningeom x meta ložisko v rámci zákl dg. U nás prvovyšetření**

Aktuální klinicky stav: **pravostranný vestibulární syndrom - nystagmus horizontálně rotatorický dolevabijící II.st, Hauntant doprava, Romberg s tahem za pravým uchem**